



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 27 — Acidentes por Animais: mordeduras e profilaxia da raiva; animais peçonhentos (serpentes, escorpiões, aranhas, lagartas, himenópteros) e soroterapia

Classificação de gravidade, soro antiveneno (indicação, dose, reações), profilaxia antirrábica pós-exposição (esquema MS 2024), tétano, mordeduras humanas/animais e notificação — cenário: PS interiorano; soros conforme ponto de soroterapia pactuado

Código	PS-ND-27	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

O interior paulista concentra os acidentes por **escorpião** (*Tityus serrulatus* — o mais frequente e o mais letal em crianças), **serpentes** (*Bothrops* — jararaca — ~85%; *Crotalus* — cascavel — ~10%), **aranhas** (*Loxosceles*, *Phoneutria*) e **abelhas**, além das mordeduras de cão/gato com risco de raiva e das feridas que exigem tétano. Três decisões do PS definem o desfecho: **reconhecer o acidente e sua gravidade, aplicar o soro certo na dose certa o mais cedo possível (ou transferir para onde ele existe) e não deixar sair sem profilaxia de raiva/tétano quando indicada**. Tudo é notificação compulsória.

Fontes de ancoragem: Brasil. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde, 6ª ed. (2024)** — capítulos Acidentes por animais peçonhentos e Raiva [MS-GVS 2024]; Ministério da Saúde/FUNASA. *Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos*, 2ª ed. (2001) [MS-PEÇONHENTOS 2001]; **Ministério da Saúde. Protocolo de tratamento da raiva humana (2011) e Nota Técnica nº 8/2022-CGZV (esquema de profilaxia pós-exposição com 4 doses IM: dias 0, 3, 7 e 14)** [MS-RAIVA]; Instituto Butantan / Instituto Vital Brazil — bulas dos soros e orientações técnicas [BUTANTAN]; Ministério da Saúde. Manual de vacinação — profilaxia do tétano acidental [MS-TÉTANO]; WHO. Guidelines for the management of snakebites, 2nd ed. 2016 / Rabies vaccines: WHO position paper 2018; Stevens DL, et al. IDSA SSTI 2014 (mordeduras) [IDSA 2014]; CIATox Campinas (0800 722 6001) — orientação toxicológica 24 h.

Convenção de confiança: classificação e doses de soro conforme MS-GVS 2024/MS 2001 e bulas do Butantan; esquema antirrábico conforme NT 8/2022. **[VERIFICAR]: qual soro existe no PS e qual está no ponto de soroterapia de referência (Mogi Guaçu/Tabajara Ramos ou outro)**, vacina antirrábica e imunoglobulina/soro antirrábico (unidade de referência para SAR/IgHAR), estoque de vacina dT/dTpa e SAT/IgHAT, fluxo com a vigilância epidemiológica e o CCZ (observação do animal).

A. Animais peçonhentos

A1. Queixa e história

"Fui picado/mordido por cobra/escorpião/aranha", "dor forte e inchaço que sobe", "vista dupla, pálpebra caída, gosto ruim na boca" (crotálico), "sangrando pela gengiva/urina escura", "formigamento/dor irradiada", "vômitos e suor frio depois de picada de escorpião" (criança). Perguntar: **hora do acidente** (define o tempo até o soro), local da picada, o animal (foto/animal morto — trazer com segurança; não perder tempo caçando), atividade (roça, entulho, calçado), primeiros cuidados feitos (torniquete? corte? sucção? — retirar/orientar), alergia, comorbidades, gestação, vacinação antitetânica, peso (criança).

Regras iniciais para todos

- Lavar o local com água e sabão; **retirar torniquete/garroto**, anéis, pulseiras; manter o membro em posição neutra/elevada; repouso; não cortar, não sugar, não aplicar substâncias.
- Acesso venoso, sinais vitais, analgesia (dipirona/paracetamol; opioide se necessário — **sem AAS/AINE no botrópico** por coagulopatia), antiemético; profilaxia antitetânica conforme vacinação; **não fazer antibiótico profilático de rotina** (só se infecção/abscesso).
- Notificar (SINAN — ficha de acidente por animal peçonhento) em 24 h**; anotar hora do acidente, hora da chegada, hora do soro, número de ampolas e lote.
- O soro é a única terapia específica**; é IV, na dose total de uma vez, **igual para adulto e criança** (neutraliza o veneno, não o peso), e sem teste de sensibilidade (abandonado). Quanto mais cedo, melhor — mas nunca é "tarde demais" se há sinais de envenenamento.

A2. Serpentes — reconhecimento clínico, gravidade e soro [MS-GVS 2024; MS 2001]

Acidente	Quadro clínico	Gravidade	Soro e nº de ampolas (IV, dose única)
Botrópico (jararaca, urutu, jararacuçu — ~85%)	Local: dor, edema progressivo, equimose, bolhas, sangramento pelas marcas; sistêmico: gengivorragia, hematúria, equimoses à distância, hipotensão, LRA; coagulopatia (TC prolongado/incoagulável)	Leve: edema local discreto, TC normal ou alterado, sem sangramento. Moderado: edema evidente (2-3 segmentos), coagulopatia, sangramento leve. Grave: edema extenso (>3 segmentos), sangramento grave, hipotensão/choque, LRA, membro com síndrome compartimental	SAB (ou SABL/SABC): leve 2-4 • moderado 4-8 • grave 12 ampolas; reavaliar TC em 12-24 h: se ainda incoagulável, repetir 2 ampolas
Crotálico (cascavel — ~10%)	Pouco sinal local (parestesia); neurotóxico: ptose palpebral, fâcies miastênica, diplopia, turvação visual, disfagia; miotóxico: mialgia, urina escura (mioglobínúria) , CPK ↑, LRA ; coagulopatia em 40%	Leve: neurotoxicidade discreta, sem mialgia/urina escura. Moderado: fâcies miastênica evidente, mialgia, urina escura discreta. Grave: fâcies + mialgia intensa + urina escura evidente, oligúria, insuficiência respiratória	SAC (ou SABC): leve 5 • moderado 10 • grave 20 ampolas; hidratação vigorosa (diurese >1-2 mL/kg/h) e alcalinização para prevenir LRA; manitol se oligúria após volume
Laquético (surucucu — raro em SP; Amazônia/Mata Atlântica)	Botrópico + síndrome vagal (bradicardia, hipotensão, diarreia, cólica)	Moderado / grave	SABL: moderado 10 • grave 20
Elapídico (coral verdadeira — raro, grave)	Sem sinal local; paralisia descendente em 1-3 h: ptose, oftalmoplegia, disfagia, sialorreia, insuficiência respiratória	Sempre grave (risco de paralisia respiratória)	SAEI: 10 ampolas + neostigmina 0,05 mg/kg IV (com atropina 0,5 mg antes) se paralisia — repetir; IOT/ventilação se necessário → UTI
Não peçonhenta / "seca" (sem envenenamento)	Marcas sem edema progressivo, TC normal em 6-12 h, sem sintomas	—	Sem soro; observar 12-24 h com TC seriado (6, 12 h); tétano

Tempo de coagulação (TC) à beira-leito (tubo seco, 1–2 mL, inclinar a cada 30 s): normal ≤9 min; prolongado 10–30; incoagulável >30 min — repetir 12 e 24 h após o soro. **Não usar heparina, plasma ou plaquetas** para a coagulopatia botrópica (o soro corrige em 12–24 h); sangramento grave: soro adicional. **Síndrome compartimental** (dor intensa, tensão, déficit neurovascular): analgesia, elevação, soro adicional e avaliação cirúrgica (fasciotomia só com pressão compartimental >30–40 mmHg — Santa Casa); não fazer fasciotomia "profilática". Antibiótico só com infecção (abscesso, celulite — Protocolo 26).

A3. Escorpiões — *Tityus serrulatus* (escorpião amarelo) [MS-GVS 2024]

Gravidade	Quadro	Conduta
Leve (maioria em adultos)	Dor local (intensa, em queimação, irradiada), parestesia, eritema/sudorese local; sem sintomas sistêmicos	Sem soro ; analgesia: dipirona/paracetamol + infiltração de lidocaína 2% sem vasoconstritor 1-2 mL no local (repetir a cada 1 h até 3×) ou bloqueio; compressa morna; observar 4-6 h (crianças <10 anos: 6–12 h — podem evoluir); tétano
Moderado	Dor local + manifestações sistêmicas discretas : sudorese, náuseas/vômitos (≤2–3), taquicardia, hipertensão leve, agitação, sialorreia discreta	SAEsc (ou SAAr) 2-3 ampolas IV + suporte; observação 12–24 h; criança <10 anos: tratar como moderado com limiar baixo
Grave (crianças <10 anos são o grupo de risco)	Vômitos profusos e incoercíveis, sudorese profusa, sialorreia intensa, agitação/prostração alternadas, hipertermia, bradicardia/taquicardia, hipertensão → hipotensão, arritmia, edema agudo de pulmão, choque, convulsão, coma	SAEsc (ou SAAr) 4-6 ampolas IV imediatamente + UTI: monitor, O ₂ , volume cauteloso (EAP), ECG/troponina/ecocardiograma (miocardite), dobutamina se baixo débito, VNI/IOT se EAP; não atrasar o soro para transferir

Regra de segurança: criança <10 anos picada por escorpião amarelo = observação mínima de 6–12 h no PS com reavaliação a cada 30–60 min nas primeiras 2 h; vômitos ou sudorese = soro. Idoso e cardiopata: vigiar arritmia/EAP. Escorpião preto (*T. bahiensis*) costuma ser mais leve.

A4. Aranhas [MS-GVS 2024]

Aranha	Quadro	Conduta
<i>Phoneutria</i> (armadeira — agressiva, grande, sobre bananas/entulho)	Dor intensa imediata irradiada, edema, sudorese local; sistêmico (raro, crianças): sudorese, sialorreia, vômitos, hipertensão, taquicardia, priapismo, bradicardia, EAP, choque	Leve: analgesia + infiltração de lidocaína (como escorpião), observar 6 h. Moderado (sudorese/vômitos/HAS): SAAr 2-4 ampolas . Grave (EAP, choque, priapismo, criança): SAAr 5-10 ampolas + UTI
<i>Loxosceles</i> (aranha-marrom — roupas, cantos; picada indolor à noite)	Forma cutânea (90%): dor 6–12 h depois, eritema, edema, "placa marmórea" (equimose + palidez + bolha), necrose em 3–7 dias; forma cutâneo-visceral (raro, criança): hemólise intravascular (anemia, icterícia, hemoglobinúria, LRA, CIVD), febre em 24–72 h	Cutânea leve: analgesia, compressas frias, antisséptico, elevação, prednisona 40 mg/dia (criança 1 mg/kg) 5 dias; cutânea com lesão >3 cm ou <72 h evolutiva: SALox (ou SAAr) 5 ampolas; cutâneo-visceral: SALox 10 ampolas + prednisona 1 mg/kg + hidratação vigorosa + UTI (hemólise/LRA); hemograma, LDH, bilirrubinas, creatinina, urina; dapsona: não (G6PD)
<i>Latrodectus</i> (viúva-negra — litoral)	Dor local → contratura muscular, dor abdominal em tábua (simula abdome agudo), sudorese, hipertensão, priapismo	Analgesia, BZD, gluconato de cálcio 10% 10–20 mL IV lento (dor/contratura); SALatr 1-2 ampolas IM em moderado/grave (Instituto Vital Brazil) [VERIFICAR disponibilidade]
Tarântula/caranguejeira, papa-moscas	Urticária pelos pelos, dor leve	Sintomáticos; sem soro

A5. Lagartas (*Lonomia* — taturana-verde), himenópteros e outros

Agente	Quadro	Conduta
Lonomia (contato com lagartas em tronco de árvores — surtos no Sul/Sudeste)	Dor em queimação local → síndrome hemorrágica em 8-72 h: equimoses, gengivorragia, hematúria, hemorragia cerebral; coagulopatia (TC incoagulável, fibrinogênio baixo), LRA	TC seriado; SALon: moderado (coagulopatia sem sangramento) 5 • grave (sangramento) 10 ampolas ; sem plasma/heparina; outras lagartas (<i>Megalopyge</i> , <i>Automeris</i>): só dor local — compressas frias, analgesia, infiltração de lidocaína
Abelhas / vespas / marimbondos	Picada única: dor, edema local (reação local extensa >10 cm não é alergia sistêmica); anafilaxia em sensibilizados (Protocolo 12); ataque maciço (>50-100 picadas; abelha africanizada): envenenamento tóxico — vômitos, hipotensão, hemólise, rabdomiólise, LRA, IAM, hepatite	Retirar ferrões (raspar); compressa fria; anti-H1 + analgesia; anafilaxia → adrenalina IM; ataque maciço : hidratação vigorosa, diurese >1-2 mL/kg/h, alcalinização, monitor, CPK/creatinina/hemograma seriados → UTI; soro antiapílico (Butantan) em fase de disponibilização — CIATox [VERIFICAR]
Formigas (lava-pés), potó (dermatite por pederina), ouriço-do-mar, arraia, peixes (bagre)	Local	Água quente 40-45 °C (arraia/peixe), compressas, analgesia, retirada de espinhos, tétano, ATB se infecção

A6. Soroterapia — administração e reações [MS 2001; BUTANTAN]

Item	Conduta
Preparo	Diluir o total de ampolas em SF 0,9% 250-500 mL (criança: 100-250 mL); infundir IV em 20-60 min ; sem teste de sensibilidade; acesso calibroso; adrenalina, anti-H1, corticoide e material de via aérea à mão
Pré-medicação	Não rotineira (evidência controversa); em alto risco (asma, atopia grave, exposição prévia a soro heterólogo): anti-H1 (prometazina 25-50 mg IM / difenidramina) + hidrocortisona 100-200 mg IV 15-30 min antes
Reação precoce (até 2 h: urticária, prurido, rubor, broncoespasmo, hipotensão — em 10-30%)	Interromper a infusão ; anafilaxia → adrenalina IM 0,3-0,5 mg (Protocolo 12) + anti-H1 + corticoide + O ₂ /volume; após controle, reiniciar o soro mais lentamente (é indispensável); não substituir por dose menor
Reação tardia (doença do soro — 5-24 dias: febre, urticária, artralgia, adenopatia)	Prednisona 0,5-1 mg/kg/dia 5-7 dias + anti-H1; orientar na alta
Soro indisponível no PS	Transferir imediatamente para o ponto de soroterapia com o paciente estabilizado (não esperar sintomas em acidente com sinais de envenenamento); acionar CIATox para orientar; anotar horas. Pontos de referência regionais [VERIFICAR — Mogi Guaçu/Tabajara Ramos; Campinas]

B. Mordeduras e profilaxia da raiva

B1. Mordedura — ferida

Item	Conduta
Lavagem	Água corrente e sabão abundante por 15 min (a medida mais eficaz contra raiva e infecção) — antes de qualquer outra coisa; irrigar com SF sob pressão; retirar corpos estranhos; explorar (tendão, articulação, osso)
Antissepsia	Iodopovidona ou clorexidina após a lavagem
Fechamento	Não suturar mordedura de rotina (risco de infecção e raiva); sutura primária frouxa só em face (estética) após lavagem exaustiva, com antibiótico; mão: não suturar; ferida >8-12 h: deixar aberta; se suturar com indicação de soro antirrábico, infiltrar o soro antes
Antibiótico	Profilático (3-5 dias) : mordedura de gato (80% infectam), mão/face/genitália/perto de articulação/osso, ferida puntiforme profunda, imunossuprimido/asplênico/DM/cirrose, sutura, >8 h. Terapêutico (7-14 dias) se infectada. Amoxicilina-clavulanato 875/125 mg 12/12 h (criança 45 mg/kg/dia); alergia: doxiciclina 100 mg 12/12 h ou SMX-TMP + clindamicina; IV grave: ampicilina-sulbactam 3 g 6/6 h. Mordedura humana: mesmo esquema (<i>Eikenella</i>)
Tétano	Conforme B4
Raiva	Conforme B2/B3
Cirurgia	Lesão de tendão/nervo/articulação/osso, mão (espaço profundo), face extensa, perda de substância, infecção profunda → Santa Casa (cirurgia/ortopedia)
Hepatite B/HIV (mordedura humana)	Avaliar exposição a sangue; profilaxia conforme protocolo de exposição (vacina HB/IGHB; HIV se agressor de risco) — vigilância

B2. Profilaxia pós-exposição da raiva — classificação do animal e da exposição [MS-GVS 2024; NT 8/2022]

Animal	Situação	Conduta
Cão / gato passível de observação, saudável no momento	Ferida leve : superficial, tronco/membros (exceto mãos/pés), única/poucas, sem lambadura de mucosa	Observar o animal por 10 dias (CCZ/vigilância); se permanecer sadio: encerrar; se adoecer/morrer/desaparecer: vacina (4 doses: dias 0, 3, 7, 14)
	Ferida grave : cabeça/face/pescoço/mãos/pés/polpas digitais, profunda, múltipla, extensa, lambadura de mucosa/pele lesada	Iniciar vacina (dias 0 e 3) e observar o animal 10 dias; se sadio ao 10º dia, suspender; se adoecer/morrer/desaparecer: completar 4 doses + soro/imunoglobulina (SAR 40 UI/kg ou IgHAR 20 UI/kg) na ferida o mais cedo possível (até o 7º dia da 1ª dose de vacina)
Cão/gato raivoso, morto, desaparecido, suspeito (sintomas, agressão sem provocação, área de raiva)	Leve	Vacina 4 doses (0, 3, 7, 14)
	Grave	Vacina 4 doses + SAR/IgHAR (infiltrar na ferida; restante IM distante da vacina)
Morcego (qualquer contato, mesmo sem lesão visível), animal silvestre (macaco, raposa, gambá, guaxinim, capivara? — mamíferos), animais domésticos de interesse econômico (bovino, equino) com sinais	Qualquer exposição	Sempre grave: vacina 4 doses + SAR/IgHAR — mesmo contato indireto com morcego dentro de casa durante o sono
Roedores urbanos (rato, camundongo), coelho, lebre	—	Sem profilaxia (não transmitem); cuidado com a ferida
Exposição indireta (objetos, lambadura de pele íntegra)	—	Sem profilaxia; lavar
Pessoa previamente vacinada (esquema completo)	Qualquer	2 doses (dias 0 e 3) ; sem soro (independentemente da gravidade); se esquema incompleto/>anos: avaliar como não vacinado

Vacina antirrábica (cultivo celular — Vero): 0,5 mL IM no deltoide (criança <2 anos: vasto lateral da coxa); **nunca no glúteo**; esquema pós-exposição **4 doses: dias 0, 3, 7 e 14** (NT 8/2022 — substituiu o esquema de 5 doses); imunossuprimido: 5 doses (dia 28) + sorologia. **SAR (soro heterólogo equino) 40 UI/kg** ou **IgHAR (imunoglobulina humana) 20 UI/kg**: infiltrar o máximo possível na(s) ferida(s) e o restante IM em local distante da vacina; dose única; **até o 7º dia após a 1ª dose de vacina** (depois, não indicar); soro heterólogo: risco de reação (como A6) — IgHAR preferida em gestante, imunossuprimido, reação prévia [VERIFICAR onde está disponível — unidade de referência regional]. Gestação e lactação **não contraindicam** vacina nem soro. Não interromper a profilaxia por reações leves.

B3. Raiva humana — suspeita

Mordedura/contato com morcego ou animal suspeito semanas a meses antes + parestesia/dor no local, febre, ansiedade, **hidrofobia/aerofobia, espasmos de deglutição, sialorreia, agitação alternada com lucidez**, paralisia ascendente (forma parálitica — morcego). **Notificação imediata**, isolamento com precaução de contato, coleta (saliva, biópsia de pele da nuca, LCR) pela vigilância, transferência para referência (Protocolo de Recife — UTI); profilaxia dos contatos com exposição a saliva/mucosas.

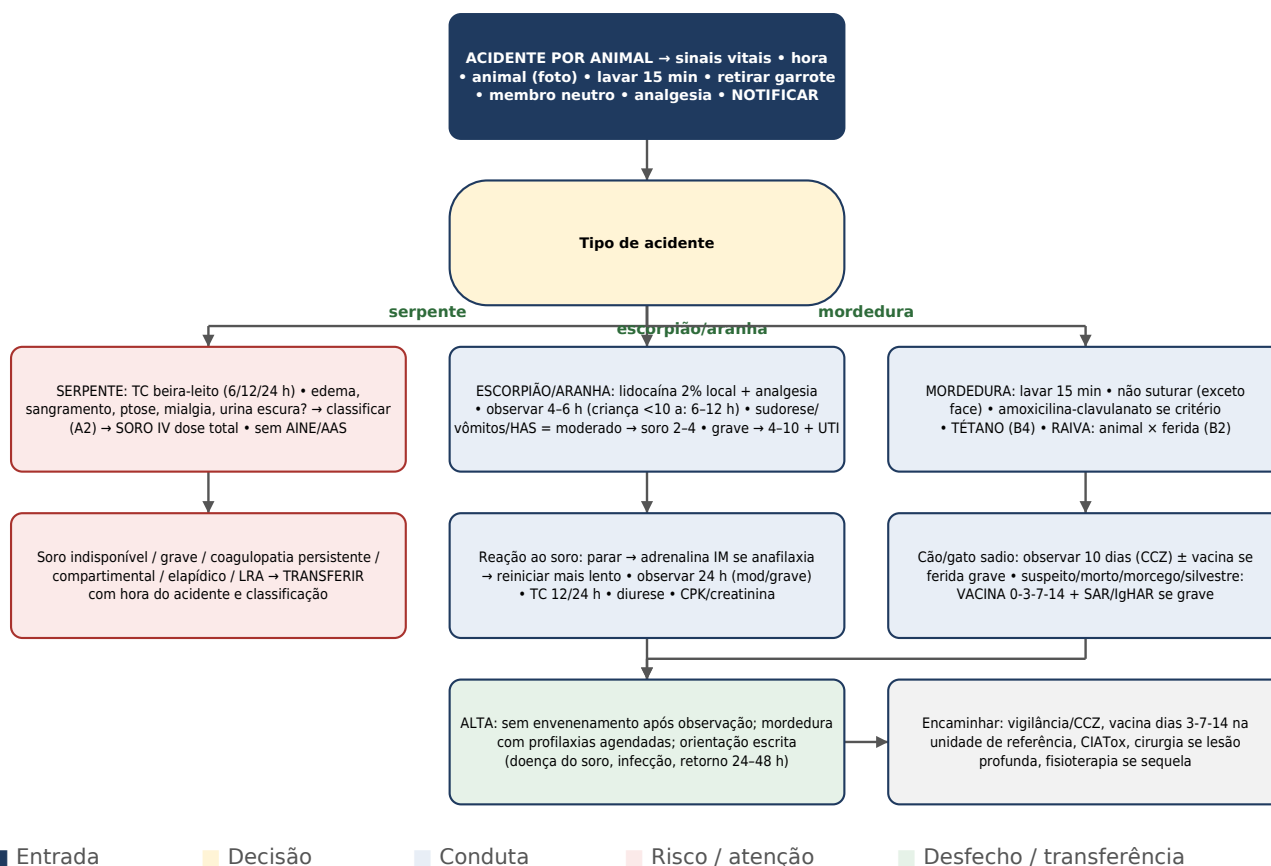
B4. Profilaxia do tétano acidental [MS-TÉTANO]

História vacinal (dT/dTpa)	Ferida limpa e superficial	Ferida de risco (suja, profunda, puntiforme, mordedura, queimadura, corpo estranho, necrose, >6 h, esmagamento)
≥3 doses, última <5 anos	Nada	Nada
≥3 doses, última 5-10 anos	Nada	Vacina (dT)
≥3 doses, última >10 anos	Vacina	Vacina (+ SAT/IgHAT se ferida de alto risco em imunossuprimido/desnutrido/idoso)
<3 doses, incerta ou desconhecida	Vacina (completar esquema)	Vacina + SAT 5.000 UI IM (ou IgHAT 250 UI IM) em locais diferentes; completar 3 doses (0, 2, 4-8 meses)

Gestante: dTpa a cada gestação (a partir da 20ª semana) — usar dTpa na profilaxia se elegível. Limpeza e desbridamento da ferida são parte da profilaxia. Registrar no cartão.

6. Fluxo de atendimento

Três vias que começam iguais (lavar, hora, animal, analgesia, notificar) e divergem pelo agente. **Soro na dose total, IV, sem esperar piora; profilaxia de raiva e tétano decididas antes da alta.**



6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → lavagem, analgesia, classificação, TC (serpente)	≤30 min
Acidente com sinais de envenenamento → soro iniciado (ou transferência para o ponto de soro)	≤1 h da chegada (o mais precoce possível após o acidente)
Escorpião em criança <10 anos → reavaliação	A cada 30 min nas primeiras 2 h; observação 6-12 h
Mordedura → lavagem 15 min	Na triagem, antes do médico
Exposição de risco de raiva → 1ª dose de vacina	No mesmo dia (dia 0); SAR/IgHAR o mais cedo possível (≤7 dias da vacina)
Notificação SINAN	≤24 h (raiva humana suspeita: imediata)

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir / internar

Situação	Urgência	Destino
Soro indicado e indisponível no PS	Imediata (estabilizado; hora do acidente no relatório)	Ponto de soroterapia de referência [VERIFICAR: Tabajara Ramos / outro]
Botrópico/crotálico grave, elapídico, laquético, escorpiônico/araneísmo grave (EAP, choque, criança), loxoscelismo visceral, <i>Lonomia</i> com sangramento, ataque maciço de abelhas, LRA, insuficiência respiratória	Imediata (soro iniciado se disponível)	UTI — Tabajara Ramos
Botrópico moderado (soro feito) sem leito de observação 24 h; coagulopatia persistente em 24 h; síndrome compartimental; mordedura com lesão profunda/mão/face extensa; infecção grave	Mesmo dia	Enfermaria (Tabajara Ramos) / cirurgia-ortopedia (Santa Casa)
Raiva humana suspeita	Imediata, com isolamento	Referência (Protocolo de Recife) — vigilância estadual
Leve sem envenenamento após observação; mordedura tratada	Alta com profilaxias agendadas	UBS / unidade de vacina antirrábica / CCZ

8.2 Transporte e documentação

- Membro imobilizado em posição neutra/elevado; acesso; monitor se sistêmico; adrenalina e anti-H1 na ambulância se soro em curso (reação tardia à infusão).
- Relatório: **animal (foto), hora do acidente, local e evolução do edema (marcar), TC seriado, classificação de gravidade, soro (tipo, nº de ampolas, lote, hora, reações), analgesia, tétano/raiva feitos ou pendentes**, diurese/cor da urina, CPK/creatinina, comorbidades.
- Regulação: CROSS-SP / SAMU 192; CIATox 0800 722 6001.

8.3 O que o PS precisa ter [VERIFICAR — definir com a vigilância se o PS será ponto de soro]

- Se ponto de soroterapia: SAB (≥ 12 ampolas), SAC (≥ 20), SAEsc/SAAr (≥ 10), SALox (≥ 10), SAEI (≥ 10 , ou fluxo), SALon (fluxo) — geladeira 2–8 °C, controle de validade; adrenalina, anti-H1, corticoide, material de via aérea; tubos para TC; lidocaína 2% sem vasoconstritor.
- Vacina antirrábica e dT/dTpa disponíveis (ou fluxo para a unidade de referência no mesmo dia); SAT/IgHAT; SAR/IgHAR (unidade de referência).
- Fichas SINAN (animal peçonhento; atendimento antirrábico humano; acidente de trabalho se ocupacional); telefone do CCZ/vigilância para observação do animal; tabela de soros e doses afixada; identificação de serpentes/escorpiões da região.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de acidentes com hora do acidente, animal, classificação de gravidade e TC (serpente) documentados	≥95%
% de envenenamentos com soro iniciado em ≤1 h da chegada (ou transferência acionada em ≤30 min se indisponível)	≥90%
% de crianças <10 anos com escorpião observadas ≥6 h e reavaliadas a cada 30 min nas 2 primeiras horas	100%
% de mordeduras com lavagem documentada, avaliação de tétano e de raiva registradas antes da alta	100%
% de exposições de risco com vacina dia 0 no mesmo dia e soro/IgHAR quando indicado	≥95%
% de notificações SINAN em 24 h	100%
Uso de AINE/AAS em botrópico; torniquete não retirado; sutura de mordedura fora de face; antibiótico profilático em picada sem indicação (eventos)	0 / registrar
Reações ao soro (precoce/tardia) registradas e tratadas	Registrar

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Esquema antirrábico	NT 8/2022-CGVZ: 4 doses (0, 3, 7, 14) — substituiu o de 5 doses; imunossuprimido: 5 doses. Adotado; conferir edição vigente do GVS [VERIFICAR]
Pré-medicação do soro	MS 2001: não rotineira; alguns serviços fazem em todos. Adotada só em alto risco
Teste de sensibilidade ao soro	Abandonado (MS/OMS) — não fazer
Nº de ampolas	Conforme MS-GVS 2024/bulas Butantan; alguns serviços usam SAB 4/8/12. Adotado 2-4/4-8/12 (MS)
Escorpião leve em criança	MS: observação; alguns protocolos: soro em toda criança <7 anos. Adotado: observação 6-12 h com limiar baixo para soro
Loxoscelismo — soro	MS: SALox 5 (cutânea) / 10 (visceral); evidência de benefício após 48-72 h é limitada. Adotado o MS
Latrodectismo / soro antiapílico	SALatr (Vital Brazil) e soro antiapílico (Butantan, em disponibilização) — acesso via CIATox [VERIFICAR]
Antibiótico em mordedura	IDSA 2014: profilático em situações definidas; prática: em todas. Adotados os critérios IDSA
Ponto de soroterapia e unidade de SAR/IgHAR	Decisão estrutural: definir com a vigilância se o PS estoca soros [VERIFICAR/PACTUAR]

10. Referências

- Brasil. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. 6ª ed. Brasília: MS, 2024 — capítulos Acidentes por animais peçonhentos; Raiva. Brasil. Ministério da Saúde/FUNASA. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2ª ed. Brasília, 2001.
- Brasil. Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 8/2022-CGZV/DEIDT/SVS/MS — esquema de profilaxia pós-exposição da raiva com 4 doses; Protocolo de tratamento da raiva humana no Brasil (Protocolo de Recife), 2011; Normas técnicas de profilaxia da raiva humana, 2014.
- Instituto Butantan. Bulas dos soros antibotrópico, anticrotálico, antibotrópico-crotálico, antibotrópico-laquélico, antielapídico, antiescorpiônico, antiaracnídeo, antiloxoscélico, antilonômico; orientações técnicas. Instituto Vital Brazil — soro antilatrofético.
- Brasil. Ministério da Saúde. Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) e Manual de vacinação — profilaxia do tétano acidental (edição vigente).
- World Health Organization. Guidelines for the management of snakebites. 2nd ed. New Delhi: WHO-SEARO, 2016. WHO. Rabies vaccines: WHO position paper — April 2018. Wkly Epidemiol Rec 2018;93:201-220.
- Stevens DL, et al. IDSA practice guidelines for skin and soft tissue infections: 2014 update (animal and human bites). Clin Infect Dis 2014;59:e10-e52.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulos de acidentes por animais peçonhentos e mordeduras (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração